



נוהל מס': 010.14
שם הנוהל: טיפול ב GBS בחדר לידה
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום הנוהל: מיילדות		תאריך פרסום:
	שם הנוהל: טיפול ב GBS בחדר לידה		ספט' 2014
	כותב הנוהל: דר' אנה קונצביץ', דר' פטר יעקובי		מהדורה:
	מאשר הנוהל:		תאריך עדכון:
	האחראי על ביצוע הנוהל:	פרופ' זאב וינר על החתום:	נספחים:
	פרופ' זאב וינר על החתום:		
מס' דפים: 7			

תוכן העניינים

<u>העמוד</u>	<u>הנושא</u>
2	1. רקע רפואי
3	2. הוראות לטיפול אנטיביוטי
4	3. תרשים בירור וטיפול GBS בלידה מוקדמת (עד 37 שבועות מלאים)
5	4. תרשים בירור וטיפול GBS בירידת מים מוקדמת (עד 37 שבועות מלאים)
6	5. טבלה של טיפול אנטיביוטי GBS בחדר לידה
7	6. סימוכין

רקע רפואי

סטרפטוקוקוס ביתא המוליטי מקבוצה B (*Streptococcus agalactiae*) (GBS) הוא אחד מהגורמים המשמעותיים לתחלואה ותמותה זיהומית של היילוד, משני סוגים:

- תחלואה מוקדמת המתרחשת בשבוע הראשון של חיי הילוד
- תחלואה מאוחרת (מלאחר שבוע ועד 90 יום) שבשניהם הביטוי הקליני דומה: אלח דם, דלקת ריאות, דלקת קרום המוח, דלקת בעצם או בפרק או בעור. נשאות מוגדרת כמצב בו החיידק נמצא בלדן האישה או בפי הטבעת ללא תסמינים קליניים כלשהם. הנשאות יכולה להיות קבועה או חולפת. החיידק עלול לעבור לילוד מן האם באמצעות שאיפה של נוזל השפיר הנגוע או באמצעות הדבקה בעת המעבר בתעלת הלידה. הסכנה לזיהום מוגברת בלידה מוקדמת. לא ידוע על העברה אנכית מהאם לעובר במהלך הריון ללא פקיעת קרומי מי השפיר או ללא תהליך לידה פעיל.

שיעור נשאות ל- GBS בארץ נע בין 12.3%-16.4% (14.2% בממוצע - נמוך בהשוואה לארה"ב - שיעור הנשאות בארה"ב מוערך בכ-30%-10%). השיעור היארעות של תחלואת ילודים מוקדמת מ- GBS בישראל היה 0.23-0.26/1000 לידות חי - השיעור הזה נמוך מהתחלואה בארה"ב ובאירופה (הכנסת הטיפול המונע באנטיביוטיקה במהלך הלידה הביאה בארה"ב לירידה ב 70% בתחלואה נאונטלית מ- GBS מאז, מ-1.7/1000 לידות חי ל-0.4-0.6/1000 לידות חי).

אשר על כן עמדת האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה אינה מצדיקה ביצוע בדיקות סקר לנשאות ל- GBS לכלל הנשים ההרות.^(1,2)

- אשה הרה עם תרבית רקטו-וגינלית חיובית ל- GBS נמצאת בסיכון גבוה פי 25 ללידת יילוד עם זיהום מוקדם מאשר נשים עם תרבית שלילית
- מתן אנטיביוטיקה לאם הנמצאת בסיכון להעברת החיידק לילוד במהלך הלידה עשוי למנוע את המחלה המוקדמת.^(1,2)

הוראות לטיפול אנטיביוטי – Intrapartum GBS prophylaxis:

1. היסטוריה של ילוד חולה במחלת GBS (מנינגיטיס, בקטראמיה)
2. GBS בקטראוריה במהלך הריון נוכחי
3. משטח מנרתיק או פי הטבעת חיובי ל-GBS שנלקח סמוך ללידה
4. GBS-סטטוס אינו ידוע בנוכחות של גורמי סיכון הבאים:
(נא לבצע משטח ל GBS לפני התחלה של טיפול אנטיביוטי אמפירי)
 - לידה לפני 37 שבועות מלאים.
 - ירידת מים הנמשכת מעל 18 שעות.
 - חום במהלך הלידה מעל 38.0 מעלות

(הגדרת חום בלידה: חום מעל 38.0 מעלות בשתי מדידות בהפרש של שעה, ללא טיפול תרופתי להורדת חום)

אין צורך בטיפול אנטיביוטי במיקרים הבאים:

1. תרבית חיובית ל GBS - בהריון קודם
2. ניתוח קיסרי מתוכנן ללא לידה או פקיעת קרומי מי השפיר (ללא קשר לתוצאות תרבית ל-GBS)

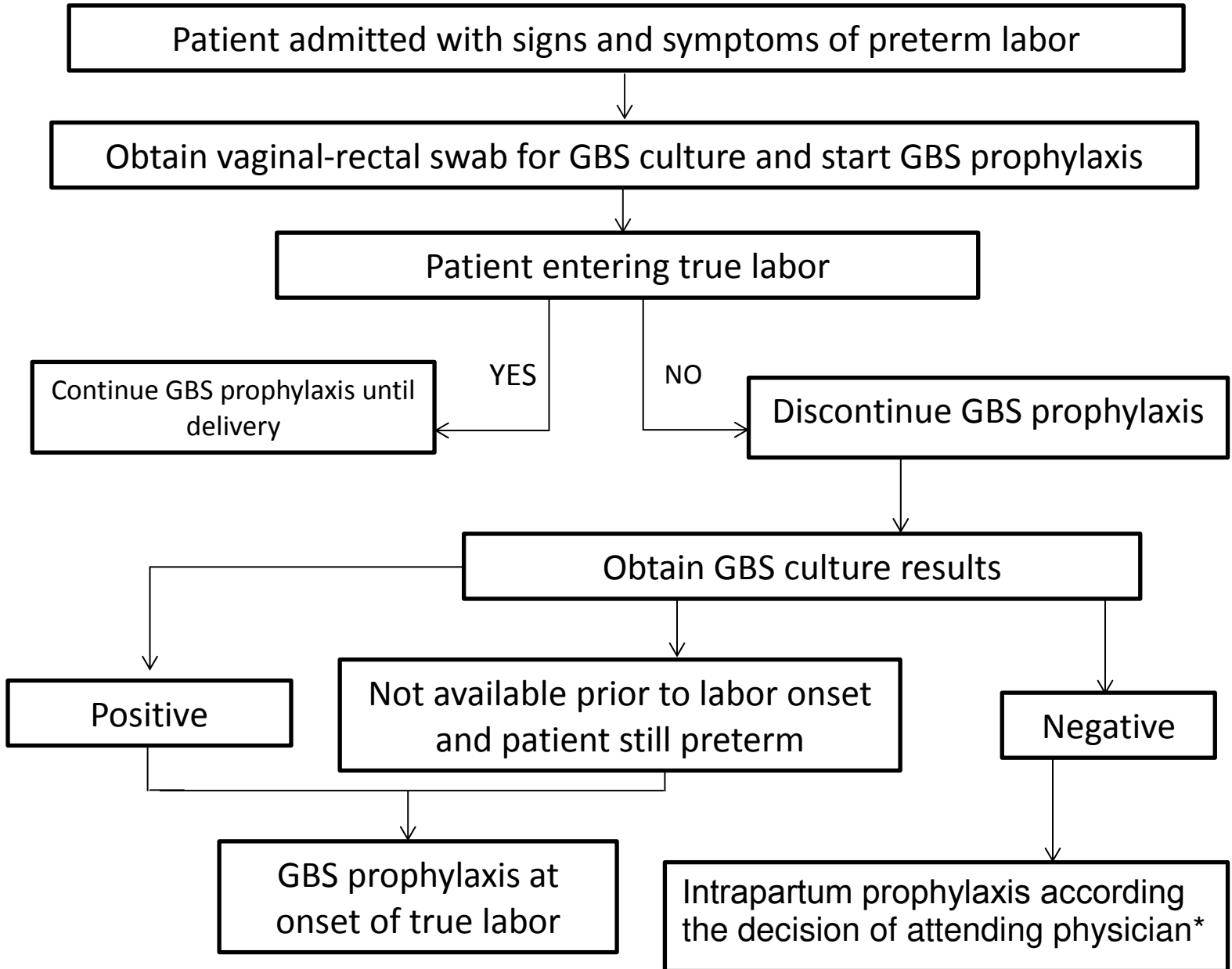
במחלקתנו הוחלט שאין להתחשב בתוצאות של "סקרינינג" שליליות בנוכחות של גורמי סיכון!

הטיפול המונע הוא אופטימלי אם ניתן כ- 4 שעות לפני הלידה, אך עדיין קיימת תועלת במתן של טיפול אנטיביוטי מונע במשך זמן קצר יותר.^(3,7)

אופן לקיחת תרבית ל-GBS -

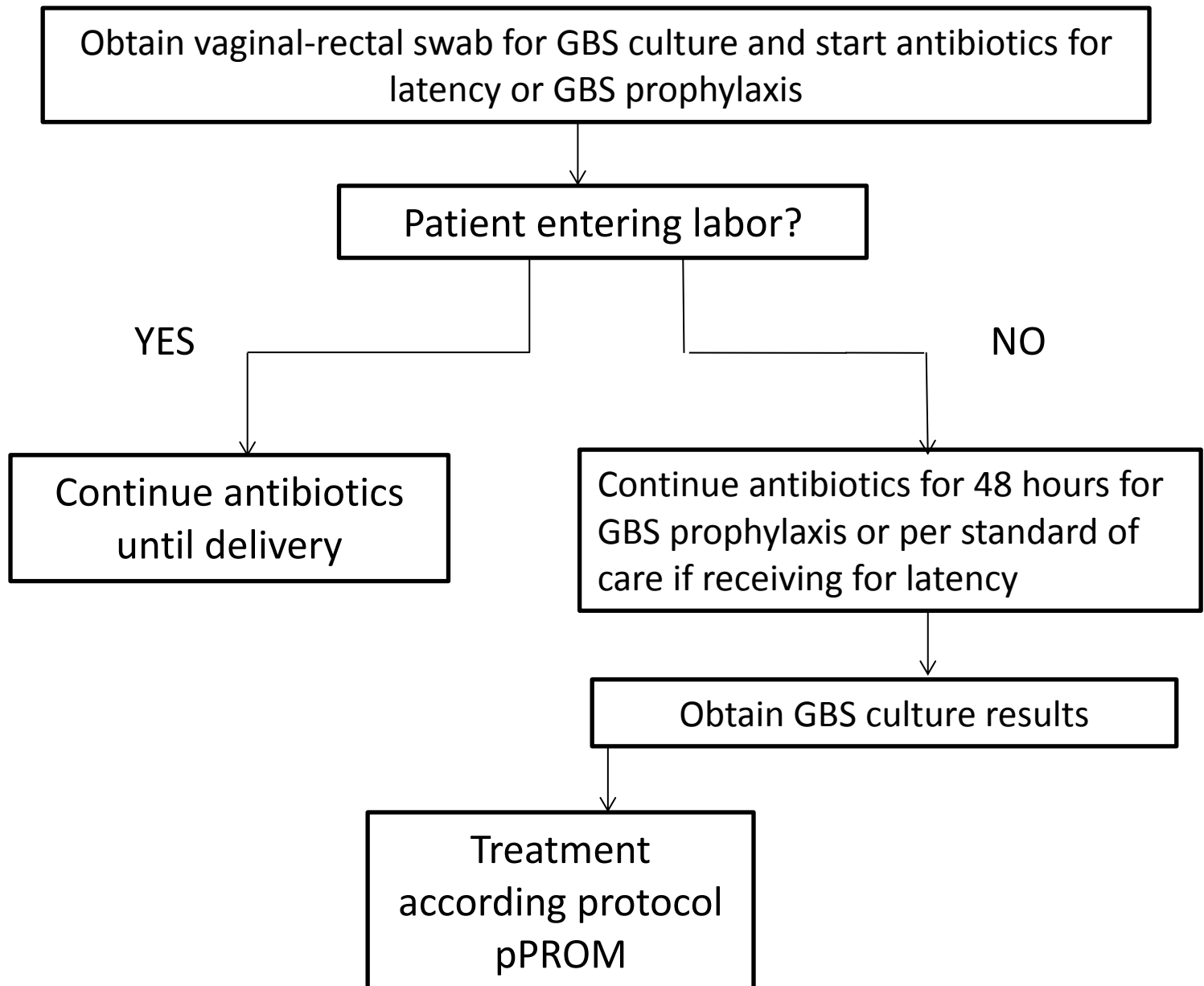
1. יש לקחת משטח בעזרת מטוש מהאזור התחתון של הלדן (vaginal introitus) ולאחר מכן מהרקטום (ניתן להשתמש במטוש אחד או שניים). אין צורך להשתמש בספקולום.
2. יש לשים את המטוש ב transport medium - המאפשר הישרדות של GBS עד 4 ימים בטמפרטורת החדר או בקרור.
3. יש לציין על טופס הבדיקה שמדובר בתרבית ל GBS - וכן לציין האם קיימת רגישות של המטופלת ל Penicillin-, על מנת שהמעבדה תבצע במידה של תרבית חיובית, בדיקת רגישות ל Clindamycin ו-Erythromycin

תרשים בירור וטיפול GBS בלידה מוקדמת (עד 37 שבועות מלאים). הותאם ממקורות 4-6



* מדובר ביולדת מאושפזת במחלקת יולדות

תרשים בירור וטיפול GBS בירידת מיים מוקדמת (עד 37 שבועות מלאים). הותאם ממקורות 4-6



טבלה של טיפול אנטיביוטי GBS בחדר לידה

Recommended	Penicillin G, 5 million units IV initial dose, then 2.5 million units IV every 4 hours until delivery
Alternative	Ampicillin, 2 g IV initial dose, then 1 g IV every 4 hours until delivery
If penicillin-allergic *	
Patients not at high risk for anaphylaxis	Cefazolin 2 g IV initial dose, then 1 g every 8 hours until delivery
Patients at high risk for anaphylaxis GBS susceptible to clindamycin and erythromycin	Clindamycin, 900 mg IV every 8 hrs until delivery OR Erythromycin, 500 mg IV every 6 hrs until delivery
Patients at high risk for anaphylaxis GBS resistant to clindamycin or erythromycin or susceptibility unknown	Vancomycin 1 g IV every 12 hours until delivery

*History of penicillin allergy should be assessed to determine whether high risk for anaphylaxis is present.

Penicillin-allergic patients at high risk for anaphylaxis are those who have experienced immediate hypersensitivity to penicillin (e.g., angioedema or urticaria) including a history of penicillin-related anaphylaxis.

סימוכין:

1. מניעת תחלואה פרינטלית ע"י סטרפטוקוקוס B מקבוצה בנשים הרות בישראל. נייר עמדה מס' 22, אפריל 2011, האגודה הישראלית למיילדות לגניקולוגיה.
http://www.obgyn.org.il/nlarEmda_info.asp?info_id= 72798
2. Ministry of health Israel - חוזר מס' 22/2005, חוזר מנכ"ל משרד הבריאות -
3. Committee on Infectious Disease and Committee on Fetus and Newborn Recommendations for the Prevention of Perinatal Group B Streptococcal (GBS) Disease. Pediatrics, Aug 2011, Vol 128: 3
4. American College of Obstetricians and Gynecologists, Committee on Obstetric Practice. Prevention of early-onset group B streptococcal disease in newborns. ACOG committee opinion. No. 482, 2011. Obstet Gynecol. 2011;117(4):1019- 27
5. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease-revised guidelines from CDC 2010.. MMWR 2010; 59 (RR-10):1–36.
6. American College of Obstetricians and Gynecologists, Use of prophylactic antibiotics in labor and delivery. ACOG Practice Bulletin No.120, June 2011. Obstet Gynecol. 2011;117 (6):1472-83.
7. Mark Turrentine, MD Intrapartum antibiotic prophylaxis for Group B Streptococcus: has the time come to wait more than 4 hours? American Journal of Obstetrics & Gynecology/ Volume 211, Issue 1, Pages 15–17, July 2014